

Транзиторная ишемическая атака

Диагноз, который держится на анамнезе: два определения и 24 часа, мимики и хамелеоны, топография по симптомам, ABCD² и цена отсрочки

Преходящая очаговая симптоматика: что это было и что с этим делать на линии.
Отличие от мигренозной ауры, приступа, синкопе и функционального расстройства;
редкие маски самой ТИА; тактика по действующему алгоритму.

Серия «Крещение поворотом» · версия 1.1 · 19 августа 2026 · CC BY-NC-SA 4.0

Клинический случай

Слово бригаде

“Вызов к пожилой женщине, постоянной пациентке бригады. Обычный повод к её вызовам — повышение артериального давления; в этот раз повод иной — задержка мочи.

На месте обращает на себя внимание изменение привычного поведения: дверь открывала долго, во время осмотра закрылась в туалете, передвигалась замедленно, была подавлена. Основная жалоба — задержка мочи, однако при пальпации напряжённый переполненный мочевого пузырь не определяется. Выполнена катетеризация мочевого пузыря, выведено немногим менее литра мочи нормального цвета — не мутной, без примеси крови.

Объективно: температура не повышена, артериальное давление 130/70 мм рт. ст. — привычные для пациентки значения, SpO₂ 98 %. Оказана посильная помощь, бригада готовится к завершению вызова.

На вопрос о самочувствии при прощании пациентка отвечает бессвязным набором слов: «сметанка... болит, болит подствольник...» — и повторяет эту речевую несурязицу. При целенаправленном осмотре: сила в руках не снижена, пробу Барре выполняет без опускания рук; выявлены лёгкая асимметрия угла рта и девиация языка вправо. По шкале LAMS — 1 балл.

Совокупность остро возникшей спутанности, речевого нарушения и очаговых знаков заставила пересмотреть повод к вызову: вместо задержки мочи — острое нарушение мозгового кровообращения. По дороге в стационар речь восстановилась, бормотание прекратилось, пациентка отвечала на вопросы по существу.”

Разбор случая приведён в конце материала.

Вопросы для размышления

Ответы — в конце материала.

1. Сколько часов в определении ТИА по российским клиническим рекомендациям и чем это отличается от формулировки Американской ассоциации сердца?
2. Насколько велик риск инсульта в первые дни после ТИА и в какой момент он максимален?
3. Как по характеру симптомов отличить ТИА от мигренозной ауры, фокального приступа и синкопе, если на момент осмотра всё уже прошло?
4. Какие симптомы указывают на каротидный бассейн, а какие — на вертебробазилярный?
5. Что оценивает шкала ABCD², чего она не оценивает и почему низкий балл не разрешает оставить пациента дома?
6. Чем тактика при ТИА по действующему алгоритму отличается от тактики при состоявшемся инсульте?

Определение: сколько часов в диагнозе

Понятие транзиторной ишемической атаки появилось в 1950-х годах: Ч. Миллер Фишер и другие заметили, что ишемическому инсульту нередко предшествуют преходящие симптомы в том же артериальном бассейне. Исходный критерий был временным: длительность симптоматики менее 24 часов.

Сегодня действуют два разных определения, и различие между ними надо знать точно, потому что в отечественных документах 24 часа **никуда не исчезли**.

Документ	Определение ТИА	Роль 24 часов
Клинические рекомендации МЗ РФ «Ишемический инсульт и транзиторная ишемическая атака», ID 814, 2024 г.	Транзиторный эпизод неврологической дисфункции вследствие фокальной ишемии головного мозга без формирования очага инфаркта	Входит в критерии. Критерий 1: симптомы длятся ≤ 24 ч; критерий 2 (обязателен одновременно): нет признаков острого инфаркта по нейровизуализации, включая ДВИ
Предыдущая редакция тех же рекомендаций (КР 171), на которую ссылается Приложение приказа ДЗМ № 535	Синдром вследствие кратковременной (менее 24 часов) локальной ишемии мозга в каротидной или вертебрально-базилярной системе	Входит прямо в определение, требования к нейровизуализации нет
Научное заявление Американской ассоциации сердца, 2009 г.	Преходящий эпизод неврологической дисфункции вследствие фокальной ишемии мозга, спинного мозга или сетчатки без острого инфаркта	Исключены. Определение тканевое: граница не по времени, а по наличию или отсутствию инфаркта

То есть действующие российские клинические рекомендации заняли промежуточную позицию: они добавили тканевое требование (отсутствие инфаркта на нейровизуализации, включая диффузионно-взвешенное изображение), но сохранили и временное: оба критерия соединены союзом «и». Из этого следуют два следствия. Короткий эпизод — например, 30 минут — с найденным очагом на ДВИ квалифицируется как инфаркт мозга, а не ТИА — здесь отечественные рекомендации совпадают с тканевым подходом. А эпизод длительностью более суток с полным последующим регрессом и чистой нейровизуализацией по отечественным критериям в ТИА не попадает (не выполнен первый критерий) и расценивается как инсульт — по тканевому же определению это была бы ТИА. Кроме того, в тех же рекомендациях сохранён термин **преходящие нарушения мозгового кровообращения (ПНМК)** с тем же порогом: симптомы сохраняются менее 24 часов с полным восстановлением функций. Зеркально устроены и критерии инфаркта: клинические данные с сохранением симптоматики ≥ 24 часов достаточны для диагноза инфаркта без нейровизуализации, если исключены другие причины.

Почему международные документы от временной границы отказались:

- при клинически преходящих симптомах, включая эпизоды длительностью в минуты, очаг ишемического повреждения на диффузионно-взвешенной МРТ обнаруживается в значительной части случаев: в ранних сериях у 35–67 % пациентов, и вероятность найти очаг растёт с длительностью эпизода;
- ишемический инсульт требует помощи в пределах минут и часов, а не к исходу первых суток;
- фактическая длительность большинства ТИА — существенно меньше часа, обычно менее 30 минут.

Слабое место тканевого определения — его зависимость от доступности МРТ: «без острого инфаркта» проверяется томографией, а до неё ТИА остаётся клиническим

диагнозом, который держится на анамнезе. Именно поэтому временной критерий в отечественных документах и сохраняется.

Для работы на линии важно другое: ни одно из двух определений не применимо на месте вызова. Оба требуют знания того, чего у бригады нет: либо итоговой длительности эпизода (он ещё не закончился или только что закончился), либо данных нейровизуализации. Поэтому те же рекомендации вводят отдельный догоспитальный термин: **острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК)** — клинический синдром внезапно развившейся очаговой симптоматики предположительно цереброваскулярного происхождения. Это и есть диагноз бригады; термины «ишемический инсульт» и «транзиторная ишемическая атака» используются после нейровизуализации.

Практическое следствие. Различие «ТИА или инсульт» на догоспитальном этапе не устанавливается и на решение не влияет: и то, и другое — ОНМК с показанием к экстренной эвакуации. Более того, временной критерий работает только ретроспективно: на вызове неизвестно, закончится ли начавшийся час назад эпизод за 24 часа или нет, а регресс симптомов к моменту передачи в стационар не исключает найденного там очага инфаркта. Поэтому формулировка «была ТИА» в карте вызова — предположение, а не диагноз; документируется исходная картина и точное время начала симптомов.

Механизм тот же, что при инсульте: эмболия из сердца, дуги аорты или крупных артерий, реже — окклюзия перфорирующей артерии *in situ*. Симптомы регрессируют за счёт спонтанного лизиса, дистальной миграции эмбола или включения коллатералей. Отдельный вариант — гемодинамическая ТИА при критическом стенозе: эпизоды стереотипны и связаны с вертикализацией, кашлем, нагрузкой, приёмом гипотензивного средства, горячей ванной, обильной едой.

Риск инсульта после ТИА

ТИА — не «мелкое событие с хорошим исходом», а предупреждение с коротким сроком действия.

Показатель	Значение
Доля ишемических инсультов, которым предшествовала ТИА	15–30 %, нередко в тот же день
Риск инсульта на 2-е сутки	3–10 % в зависимости от способа учёта событий
Риск инсульта к 7-м суткам	5,2 % по метаанализу Giles и Rothwell (2007)
Риск инсульта к 90-м суткам	9–17 % в исследованиях 2000-х годов; 4,7 % в современных когортах с ранней профилактикой
Момент максимального риска	Первые 24 часа
Риск при активном ведении в первые сутки	90-дневный риск 2,1 % против 10,3 % при отсрочке (EXPRESS)

Ключевая особенность распределения — риск «сдвинут к началу»: около половины повторных событий приходится на первые двое суток. Отсюда прямое следствие: ценность любого действия при ТИА обратно пропорциональна задержке. Исследование EXPRESS (Оксфорд, 2007) сравнило периоды обычного ведения и срочного обследования с немедленным началом профилактики: 90-дневный риск инсульта снизился с 10,3 % до 2,1 %, медиана времени от появления симптомов до первого назначения препарата — с

20 дней до 1 дня. Исследование SOS-TIA (Париж, 2007) с круглосуточной клиникой ТИА дало 90-дневную частоту инсульта 1,24 % против предсказанных по ABCD² 5,96 %. Оба результата — около 80 % снижения, и оба получены не за счёт новых препаратов, а за счёт скорости.

Современное медикаментозное продолжение той же логики — двойная антиагрегантная терапия в стационаре: в исследованиях CHANCE и POINT комбинация ацетилсалициловой кислоты и клопидогрела, начатая в первые 24 часа при малом инсульте (NIHSS ≤ 3) или ТИА высокого риска (ABCD² ≥ 4) и продолженная 21 день, снижала частоту повторного инсульта за 90 дней. Догоспитального этапа это не касается напрямую — антиагреганты бригадой не вводятся, поскольку внутримозговое кровоизлияние без томографии не исключено, — но объясняет, зачем нужна доставка сегодня, а не запись в поликлинику на послезавтра.

Топография: какой бассейн

Симптомы ТИА должны воспроизводить известный инсультный синдром — это главное правило при разборе преходящего эпизода. Часть симптомов бассейн не различает, часть указывает на него достаточно определённо.

Симптом	Бассейн
Афазия (нарушение языка, а не артикуляции)	Каротидный (средняя мозговая артерия)
Преходящая монокулярная утрата зрения	Каротидный (глазная артерия)
Гемипарез, гемигипестезия	Не различает: встречается в обоих
Двусторонняя слабость конечностей	Вертебробазилярный
Истинное вращательное головокружение, острая утрата слуха	Вертебробазилярный
Гомонимная гемианопсия, диплопия	Вертебробазилярный
Изолированные лицо + рука + нога с одной стороны, чувствительные или двигательные	Перфорирующая артерия (лакунарный синдром)

Две оговорки, без которых таблица вредна.

Речь. Различить дизартрию и афазию по рассказу трудно, но именно это различие меняет предполагаемый бассейн. «Речь была смазанная, слова правильные» — дизартрия, признак в том числе стволовой. «Слова были не те, вставлял бессмысленные слова, не мог назвать предмет, не понимал обращённую речь» — афазия, признак поражения полушария, обычно бассейна средней мозговой артерии. Полезные вопросы: пациенту — знал ли он, какое слово хочет сказать; свидетелю — были ли слова правильными, хотя и невнятными, или это были другие, неподходящие слова. Изолированная кратковременная остановка речи, особенно повторяющаяся и стереотипная, чаще связана с приступом, а не с ТИА.

Изолированное головокружение. При жалобе «закружилось» вероятность сосудистой причины невелика: в популяционном исследовании только 3,2 % пациентов, обратившихся в отделение неотложной помощи с «головокружением», получили в итоге диагноз ТИА или инсульта. Это не разрешает игнорировать головокружение — при сопутствующих очаговых знаках, неспособности стоять и идти, впервые возникшей головной или шейной боли, направление-меняющем или вертикальном нистагме вероятность центральной причины резко возрастает. Подробно оценка острого вестибулярного синдрома и алгоритм HINTS разобраны в отдельном материале серии — «Инсульты вертебробазилярного бассейна».

Мимики: что принимают за ТИА

По данным клиник ТИА, до 60 % направленных пациентов в итоге получают другой диагноз. В серии Национального госпиталя неврологии (Лондон, 1532 последовательных обращения) определённая или возможная ТИА подтверждена у 1148 пациентов (75 %), малый инсульт — у 46 (3 %), а у 338 (22 %) обнаружился один из 25 других диагнозов. Самые частые: мигренозная аура, эпилептический приступ, синкопе, функциональное или связанное с тревогой расстройство.

Признак	ТИА	Мигренозная аура	Фокальный приступ	Синкопе	Функциональное
Возраст и пол	Пожилые, сосудистые факторы риска	Молодые, чаще женщины	Любой возраст	Любой, чаще женщины	Молодые
Характер симптомов	«Негативные»: утрата силы, чувствительности, зрения	«Позитивные», распространяющиеся: зигзаги, мерцание, парестезии; затем возможны негативные в той же сфере	«Позитивные»: подёргивания, тоническая поза, поворот головы, автоматизмы	Предсинкопальные: потемнение в глазах, «глухие» звуки, дурнота	Иногда «скандинавские»
Развитие	Максимум сразу, все симптомы вместе	Развитие за минуты и десятки минут, переход в другую модальность	Развитие за секунды в пределах одной сферы	Секунды	Внезапно
Длительность	Обычно минуты, почти всегда менее часа	10–30 минут, иногда дольше	До 2–5 минут	Секунды	До 10 минут
Сознание	Утрата практически не бывает	Утраты нет, возможна «спутанность мыслей»	Утрата или изменение осознания, амнезия эпизода	Утрата с быстрым полным восстановлением	Редко
Сопутствующее	Головная боль возможна во время эпизода	Головная боль после ауры, тошнота, светочувствительность и звукобоязнь	Прикус языка (особенно боковой), недержание, мышечные боли, послеприступная спутанность	Потливость, бледность, тошнота	После приступа
Повторы	Дни и недели, редко месяцы	Годы и десятилетия	Годы	Годы	Годы

Разбор отдельных мимиков.

Мигренозная аура — самая частая: до 20 % пациентов с подозрением на ТИА.

Трудность возникает, когда головной боли нет или она минимальна («late-life migraine accompaniment», ацефалгическая мигрень) — а именно этот вариант характерен для пожилых. Аура отражает распространяющуюся корковую депрессию, поэтому нарастает за минуты, соответствуя смежным зонам коры: парестезии из кисти поднимаются к плечу, туловищу, лицу; зрительный феномен движется по полю и оставляет за собой дефект. Переход из одной модальности в другую (сначала зрение, потом чувствительность) для одной ТИА не характерен. Наличие мигрени в анамнезе

или головной боли в начале эпизода инсульт не исключает: головная боль в дебюте описана у части пациентов с инсультом и ТИА.

Эпилептический приступ. Опорные признаки против ТИА — позитивные двигательные и чувствительные симптомы в начале, утрата осознания, амнезия эпизода, послеприступная спутанность, боковой прикус языка, мышечные боли, стереотипность повторов. Парез Тодда после приступа сохраняется часами и имитирует состоявшийся инсульт; изолированный парез как единственное проявление приступа — редкость, но встречается. Решающее значение имеет описание свидетеля именно начала эпизода.

Синкопе. Преходящая утрата сознания с утратой постурального тонуса и быстрым полным восстановлением, без истинно фокальных симптомов. Предсинкопальные ощущения объясняются глобальной, ретинальной и кохлеарной гипоперфузией: дурнота, потемнение в глазах, приглушение звуков. Причины — рефлекторное (вазовагальное) синкопе, ортостатическая гипотензия, гиперчувствительность каротидного синуса; самые опасные — аритмии, поэтому ЭКГ обязательна. Утрата сознания как проявление ТИА возможна лишь при ишемии таламусов или ствола и транзиторной бывает крайне редко.

Периферическая вестибулярная патология — доброкачественное позиционное головокружение, вестибулярный неврит, болезнь Меньера. Первый шаг — разграничить истинное вращательное головокружение, неустойчивость без вращения и предсинкопальную дурноту: слово «кружится» пациенты используют для всех трёх состояний.

Транзиторная глобальная амнезия. Внезапная утрата способности запоминать новое при сохранной процедурной памяти, обычно у людей старше 50 лет, длительностью несколько часов, с повторяющимися вопросами и последующим сохранением «провала» на период эпизода. Риск инсульта после неё не повышен. Изолированное нарушение памяти как проявление ТИА требует двустороннего поражения медиальных отделов височных долей и встречается крайне редко — поэтому «выпадение памяти без всего остального» скорее говорит против ТИА.

Функциональное расстройство — до 7 % обращений в клиники ТИА. Признаки: несоответствие жалоб данным осмотра и наблюдения, «складывающаяся» слабость, стереотипные повторы, паническая окраска, множественные симптомы, молодой возраст без сосудистых факторов риска.

Амилоидные «спеллы» — преходящие фокальные эпизоды при церебральной амилоидной ангиопатии: стереотипные, повторяющиеся, распространяющиеся за секунды-минуты парестезии, онемение или слабость. Клиническая ценность признака в другом: после таких эпизодов риск симптомного внутримозгового кровоизлияния очень высок, а антиагреганты и антикоагулянты при подтверждённой амилоидной ангиопатии противопоказаны. То есть ошибочный ярлык «ТИА» здесь не безобидная неточность, а прямой путь к назначению препарата, который повышает риск кровоизлияния.

Структурные внутричерепные образования (в частности, менингиома) и артериовенозные мальформации способны давать эпизоды, похожие на ТИА. Признаки, указывающие на структурную причину: нарастание или «спотыкающееся» течение на протяжении недель, симптомы внутричерепной гипертензии.

Пароксизмальные симптомы при демиелинизации — пароксизмальная дизартрия и болезненные тонические спазмы конечности: стереотипные, повторяющиеся, у молодых пациентов без сосудистых факторов риска.

Метаболические и лекарственные причины. Гипогликемия воспроизводит любую очаговую симптоматику вплоть до афазии и гемипареза, и это первое, что исключается

на месте: глюкометрия входит в объём алгоритма при остром нарушении мозгового кровообращения. Сюда же — интоксикации и передозировка препаратов у пожилых.

Хамелеоны: когда ТИА выглядит иначе

Обратная ошибка — не увидеть сосудистое событие под непривычной картиной.

«Трясущиеся» ТИА (limb-shaking). Ритмичные произвольные подёргивания руки или ноги при гемодинамической недостаточности на фоне тяжёлого стеноза или окклюзии внутренней сонной либо средней мозговой артерии. От фокального моторного приступа отличают: длительность менее 5 минут, отсутствие вовлечения лица, отсутствие джексоновского марша, провокация вертикализацией, кашлем, нагрузкой.

Капсулярный предупреждающий синдром (capsular warning syndrome).

Поражение одной перфорирующей артерии даёт серию флюктуирующих эпизодов гемипареза и гемигипестезии, ограниченных внутренней капсулой: многократные атаки за 24–48 часов, из-за чего их принимают за приступы или функциональное расстройство. Риск раннего состоявшегося инсульта при этом синдроме высок. Аналог для перфорантов моста — понтинный предупреждающий синдром.

Спонтанные движения и позотонические реакции при базилярной ишемии.

Ритмичные подёргивания и затяжные тонические напряжения при острой ишемии ствола легко принимаются за судорожный приступ, а являются предвестником инфаркта ствола при тромбозе базилярной артерии.

«Locked-in» ТИА. Описаны редкие эпизоды преходящего тетрапареза при сохранном сознании — транзиторный аналог синдрома «запертого человека» при стволовой ишемии.

Крепцендо-ТИА. Серия учащающихся эпизодов за короткое время (часы-дни) — картина нестабильного очага, требующая тех же действий, что состоявшийся инсульт, независимо от того, что на момент осмотра симптомов нет.

Шкала ABCD² и её границы

Шкала ABCD² оценивает риск инсульта в ближайшие дни после ТИА. Максимум — 7 баллов.

Компонент	Условие	Баллы
A — Age (возраст)	60 лет и старше	1
B — Blood pressure (АД при первом измерении)	САД $\geq$ 140 или ДАД $\geq$ 90 мм рт. ст.	1
C — Clinical features (клиника)	Односторонняя слабость	2
	Нарушение речи без слабости	1
D — Duration (длительность эпизода)	60 минут и более	2
	10–59 минут	1
D — Diabetes (диабет)	Диабет в анамнезе	1

Сумма	Группа риска	Инсульт за 2 суток	За 7 суток	За 90 дней
0–3	Низкий	1,0 %	1,2 %	3,1 %
4–5	Умеренный	4,1 %	5,9 %	9,8 %
6–7	Высокий	8,1 %	11,7–12 %	18 %

Шкала вошла в клинические рекомендации МЗ РФ отдельным приложением, причём там граница высокого риска указана как 6–8 баллов — хотя максимум по сумме компонентов равен 7.

Чего шкала не делает.

- **Не является диагностическим инструментом.** Она предполагает, что диагноз ТИА уже поставлен, и оценивает риск, а не вероятность того, что эпизод был сосудистым. Высокий балл коррелирует с истинной ТИА лишь потому, что мимики чаще дают низкий балл.
- **Не учитывает ключевые предикторы:** стеноз сонной артерии, повторные и учащающиеся эпизоды, наличие очага на диффузионно-взвешенной МРТ, источник эмболии в сердце.
- **Пропускает часть событий.** При популяционной валидации 25 % инсультов в течение 7 суток произошли у пациентов с суммой 4 баллов и ниже. В проспективной работе в отделении неотложной помощи предсказательная точность шкалы признана недостаточной ни при каком пороге отсечения.
- **Плохо переносится в руки не-специалистов:** воспроизводимость оценки вне профильной службы изучена слабо.
- **Требует завершённого эпизода.** Компонент «D — длительность» подсчитывается только тогда, когда симптомы уже регрессировали; у пациента с продолжающимся дефицитом считать его нечего — это лечится как инсульт.

Практический вывод для линии: шкала ABCD² в объём действий выездной бригады по действующему алгоритму не входит, а низкий балл сам по себе не является аргументом в разговоре о госпитализации. Догоспитальная шкала, предусмотренная алгоритмом при остром нарушении мозгового кровообращения, — LAMS, и она оценивает только моторику (асимметрия лица, дрейф руки, сила кисти, 0–5 баллов); афазию, поля зрения, координацию и стволовые знаки она не улавливает и бассейн не различает.

Догоспитальная тактика

По действующему алгоритму (Приказ ДЗМ г. Москвы № 535 от 18.05.2023, раздел «Неврология», внутренние стр. 55–57) транзиторная ишемическая атака и «синдром вертебробазилярной артериальной системы» (ТИА в вертебробазилярной системе), коды G45 и G45.0, ведутся в одном алгоритме с инсультом и инфарктом мозга.

Мероприятие	Объем по алгоритму
Обследование	Пульсоксиметрия, ЭКГ (ЭКП), глюкометрия, термометрия
Оценка дефицита	Шкала LAMS (Приложение 19)
Доступ	Катетеризация вены или внутрикостный доступ
Базовая терапия	Этилметилгидроксипиридина сукцинат 250 мг (5 мл) в/венно и Магния сульфат 2500 мг (10 мл) в разведении Натрия хлорида 0,9 % — 250 мл в/венно капельно 30–60 капель в минуту или Инозин + никотинамид + рибофлавин + янтарная кислота 10 мл в разведении Натрия хлорида 0,9 % — 400 мл в/венно капельно до 60 капель в минуту
При $SpO_2 \leq 93 \%$	Ингаляция кислорода
При САД > 200 мм рт. ст. (инсульт, инфаркт мозга)	Урапидил 12,5–25 мг (2,5–5 мл) в/венно медленно; снижение САД не более 15 % от исходного уровня
При САД < 100 мм рт. ст.	Натрия хлорид 0,9 % — 250–500 мл и/или Гидроксиэтилкрахмал 6 % — 250–500 мл в/венно капельно; при отсутствии эффекта Норэпинефрин 0,5–5 мкг/кг/мин или Допамин 5–15 мкг/кг/мин (при брадикардии) в разведении Натрия хлорида 0,9 % — 250 мл
При тахикардии ≥ 100 в минуту	Пропранолол 10–20 мг или Метопролол 12,5–25 мг внутрь (при отсутствии противопоказаний)
При гипогликемии $< 3,7$ ммоль/л	Декстроза 40 % — 20–40 мл в/венно
При гипергликемии > 10 ммоль/л	Натрия хлорид 0,9 % — 250 мл в/венно капельно
При рвоте	Метоклопрамид 10 мг (2 мл) в/венно
При головной боли	Кеторолак 30 мг (1 мл) в/венно
При психомоторном возбуждении	Диазепам 10 мг (2 мл) в/венно
При температуре тела $> 38^\circ\text{C}$	Метамизол натрия 1000 мг (2 мл) в/венно
Эвакуация	Медицинская эвакуация в больницу, транспортировка на носилках

Отдельного внимания заслуживает пункт об отказе от эвакуации: он для ТИА и для инсульта разный.

Ситуация	При инсульте, инфаркте мозга, субарахноидальном и внутримозговом кровоизлиянии	При ТИА и вертебробазилярной недостаточности
Отказ от медицинской эвакуации	Актив в ОНМПВиДН	Актив в поликлинику
Повторный отказ	Актив в поликлинику	—

Практический смысл различия: снятие симптомов не отменяет ни эвакуации, ни последующего наблюдения — меняется только адресат актива. При этом решение о том, что перед бригадой ТИА, а не инсульт, принимается не на месте, а по результатам обследования в стационаре, поэтому объём помощи и настойчивость в вопросе госпитализации остаются такими же, как при состоявшемся инсульте.

Что бригадой не выполняется: антиагреганты и антикоагулянты не вводятся (внутричерепное кровоизлияние без нейровизуализации не исключено); при дисфагии и угнетённом сознании ничего не даётся внутрь; артериальное давление рутинно не снижается — только при значениях и показаниях, оговорённых алгоритмом.

Расхождения с международной практикой. Отмечаются явно, приоритет на линии — у действующего алгоритма.

- Ранняя двойная антиагрегантная терапия (CHANCE, POINT) в международных руководствах начинается в первые 24 часа после исключения кровоизлияния — то есть в стационаре; догоспитальным этапом это не выполняется ни там, ни здесь.
- Этилметилгидроксипиридина сукцинат и комбинация инозин + никотинамид + рибофлавин + янтарная кислота, предусмотренные алгоритмом как базовая терапия, в международных руководствах по ТИА и ишемическому инсульту не рекомендованы: доказательной базы, признанной в этих документах, у них нет.
- Магния сульфат при остром ишемическом инсульте в международных руководствах как нейтропротектор не рекомендован (исследование FAST-MAG не показало улучшения исходов).
- В зарубежных системах распространён третий маршрут, которого в отечественном алгоритме нет: клиника ТИА с обследованием в течение 24 часов вместо госпитализации. Именно этот маршрут дал результаты EXPRESS и SOS-TIA. В условиях действующего алгоритма его функцию выполняет госпитализация.

Возвращение к клиническому случаю

Повод как рамка осмотра. Пациентка знакома бригаде, повод необычен для неё, но сам по себе бытовой — задержка мочи. Такой повод задаёт рамку осмотра и уводит внимание от нервной системы. Объективная находка повод не подтверждает: напряжённого переполненного мочевого пузыря нет, а выведенный объём мочи нормального цвета не объясняет ни поведения, ни последующей симптоматики. Несоответствие между поводом и находкой — первый сигнал пересмотреть картину.

Изменённое поведение — не фон, а симптом. Замедленность, подавленность, необычная для пациентки странность поведения легко списываются на возраст, характер или «плохой день». В контексте острого эпизода это проявление изменённого психического статуса, которое у пожилого пациента требует исключения сосудистой причины наравне с делирием и декомпенсацией.

Речь: афазия, а не дизартрия. «Сметанка... болит, болит подствольник» — это не смазанная артикуляция правильных слов, а неверные слова и, судя по «подствольнику», неологизм. Артикуляция сохранна, сломан язык: это парафазическая афазия беглого типа. Различие не академическое: дизартрия указывает в том числе на ствол, а беглая афазия с парафазиями — на полушарие, чаще на бассейн средней мозговой артерии.

Что даёт LAMS 1 балл. Шкала оценила три вещи: асимметрию лица, дрейф руки, силу кисти. Один балл получен за асимметрию угла рта при сохранной силе и отрицательной пробе Барре. Смысл этого балла ровно один: пирамидный путь к руке цел. Бассейн шкала не различает; высокие значения (4–5) поддерживают окклюзию крупной артерии переднего бассейна, обычно сегмента M1 средней мозговой, а единица против такой окклюзии говорит. Ни подтвердить, ни исключить задний бассейн одним баллом нельзя.

Топография по осмотру. Сочетание беглой афазии с парафазиями, минимальной асимметрии лица и полностью сохранной силы в руке укладывается в поражение нижней ветви левой средней мозговой артерии: волокна к руке идут выше, в роландову область, а зона Вернике лежит в области распределения нижней ветви. Девиация языка вправо вместе с углом рта и без пареза руки тоже лучше объясняется полушарным кортикобульбарным пучком, чем стволом: ядро VII нерва лежит в мосту, ядро XII — в продолговатом мозге, и очаг, захвативший оба ядра, но пощадивший пирамиду, был бы крайне необычным. Классические альтернирующие стволовые синдромы из описанного осмотра не собираются: Вебера, Мийяра-Гюблера и Дежерина дают парез, Валленберг — головокружение, дисфагию, синдром Горнера и перекрёстное расстройство чувствительности, ни одного из этих наборов здесь нет. В дифференциальном ряду остаются таламус (полярный или парамедианный вариант: апатия, замедленность, парафазии без гемипареза) и височно-затылочная область в бассейне задней мозговой артерии, но для них нужны поля зрения и глазодвигательные знаки, которые в этом осмотре не оценивались.

Задержка мочи как локальный знак. Понтийный центр мочеиспускания существует, но при поражении моста рядом оказываются взор, мимика по периферическому типу, слух, координация. Литр светлой мочи у пожилой женщины — слишком слабое основание для стволочной локализации: это бывает и при спутанности, и при неспособности сообщить о позыве, и вовсе без инсульта.

Мимики, которые нужно было отсечь. Делирий и депрессия объясняли бы поведение, но не дают впервые возникшей очаговой симптоматики. Гипогликемия воспроизводит и афазию, и асимметрию лица — поэтому глюкометрия здесь не формальность. Транзиторная глобальная амнезия дала бы изолированное нарушение запоминания без афазии и асимметрии. Функциональное расстройство маловероятно у пожилой пациентки с сосудистым фоном и объективными очаговыми знаками.

Регресс по дороге ничего не закрывает. Речь восстановилась в машине. Эпизод предварительно расценивается как транзиторная ишемическая атака (окончательные данные на момент подготовки материала отсутствуют, наблюдение продолжается). Именно на этот момент — первые часы после регресса — приходится максимум риска состоявшегося инсульта. Документируется исходная картина, а не состояние на момент передачи: объём обследования в стационаре определяется тем, что было, а не тем, что осталось.

Честная формулировка того, что известно. Острое нарушение мозгового кровообращения с афазией и минимальным моторным дефицитом; топографически вероятнее нижняя ветвь левой средней мозговой артерии; таламус и задняя мозговая артерия остаются в дифференциальном ряду; классический стволочный синдром не собирается. Бассейн без оценки полей зрения, координации, движений глаз и нистагма на линии не устанавливается — и на решение о доставке в инсультный центр это не влияет.

Резюме

- В российских клинических рекомендациях граница в 24 часа сохранена: критерии ТИА — симптомы ≤ 24 ч и отсутствие острого инфаркта по нейровизуализации. Временную границу убрало только тканевое определение Американской ассоциации сердца (2009).
- Ни одно из двух определений не работает на месте вызова: догоспитальный диагноз — ОНМК, а ТИА или инфаркт мозга устанавливается после нейровизуализации.
- Риск инсульта максимален в первые 24 часа: 3–10 % за 2 суток, около 5 % за 7 суток, при отсрочке помощи до 10,3 % за 90 дней против 2,1 % при ведении в первые сутки.

- ТИА и малый инсульт на линии не различаются и разделять их не требуется: и то, и другое — показание к экстренной эвакуации.
- Мимики составляют до 60 % направлений в клиники ТИА; главные — мигренозная аура (до 20 %), приступ, синкопе, функциональное расстройство, транзиторная глобальная амнезия, гипогликемия.
- Опорное различие в анамнезе: ТИА даёт негативные симптомы, максимальные сразу; аура — позитивные, распространяющиеся за минуты и переходящие в другую модальность; приступ — позитивные за секунды с утратой осознания.
- Хамелеоны ТИА: «трясущиеся» гемодинамические атаки, капсулярный и понтинный предупреждающий синдромы, движения и позотонические реакции при базилярной ишемии, крещендо-серии.
- Шкала ABCD² оценивает риск, а не диагноз, не учитывает стеноз, повторность и данные МРТ и пропускает четверть ранних инсультов; в объём действий бригады она не входит, и низкий балл не аргумент против госпитализации.
- По действующему алгоритму ТИА (G45, G45.0) ведётся вместе с инсультом; различие одно: при отказе от эвакуации при ТИА и вертебробазилярной недостаточности актив передаётся в поликлинику, при инсульте — в ОНМПВиДН.
- Антиагреганты на догоспитальном этапе не вводятся: без нейровизуализации кровоизлияние не исключено.

Ответы на вопросы для размышления

1. В действующих клинических рекомендациях МЗ РФ (ID 814, 2024) 24 часа сохранены как первый из двух критериев ТИА: симптомы длятся ≤ 24 ч и отсутствуют признаки острого инфаркта по нейровизуализации, включая диффузионно-взвешенное изображение. Там же сохранён термин ПНМК с тем же порогом и зеркальный критерий инфаркта (симптоматика ≥ 24 ч). Научное заявление Американской ассоциации сердца (2009), напротив, временную границу из определения убрало и оставило только тканевое требование — отсутствие острого инфаркта; причины: очаг на ДВИ при клинически преходящих эпизодах в 35–67 % случаев, большинство ТИА короче 30 минут, лечение нужно в пределах минут, а не суток. Для бригады неприменимы оба: на месте нет ни итоговой длительности эпизода, ни томографии, поэтому догоспитальный диагноз — ОНМК.
2. Риск состоявшегося инсульта — 3–10 % на 2-е сутки, 5,2 % к 7-м суткам, 9–17 % к 90-м дням в исследованиях 2000-х годов и около 4,7 % в современных когортах с ранней профилактикой. Максимум приходится на первые 24 часа, около половины ранних событий — на первые двое суток. Срочное обследование и немедленное начало профилактики снижают 90-дневный риск с 10,3 % до 2,1 % (EXPRESS).
3. По характеру и развитию симптомов. ТИА: негативные симптомы (утрата силы, чувствительности, зрения), максимум сразу, все симптомы вместе, длительность минуты, почти всегда менее часа, утрата сознания практически не бывает. Мигренозная аура: позитивные симптомы (зигзаги, мерцание, парестезии), нарастание за минуты и десятки минут, распространение по смежным зонам и переход в другую модальность, длительность 10–30 минут, затем головная боль с тошнотой и свето- и звукобоязнью. Фокальный приступ: позитивные симптомы за секунды в пределах одной сферы, утрата осознания и амнезия эпизода, послеприступная спутанность, боковой прикус языка, парез Тодда после приступа, стереотипность повторов. Синкопе: предсинкопальная дурнота, потемнение в глазах, приглушение звуков, утрата сознания на секунды с быстрым полным восстановлением, потливость и бледность, без истинно фокальных симптомов.

4. На каротидный бассейн указывают афазия и преходящая монокулярная утрата зрения; на вертебробазилярный — двусторонняя слабость конечностей, истинное вращательное головокружение, острая утрата слуха, гомонимная гемианопсия, диплопия. Гемипарез и гемигипестезия бассейна не различают. Симптомы, ограниченные одной стороной по типу лакунарного синдрома, указывают на перфорирующую артерию. Изолированное головокружение чаще периферическое: диагноз ТИА или инсульта получают 3,2 % пациентов, обратившихся с «головокружением».

5. ABCD² складывает возраст 60 лет и старше (1), АД $\geq 140/90$ мм рт. ст. (1), одностороннюю слабость (2) или нарушение речи без слабости (1), длительность ≥ 60 минут (2) или 10–59 минут (1), диабет (1). Сумма 0–3 — риск инсульта 1,0 % за 2 суток, 4–5 — 4,1 %, 6–7 — 8,1 %. Шкала не оценивает вероятность того, что эпизод был сосудистым, не учитывает стеноз сонной артерии, повторность эпизодов, кардиальный источник эмболии и данные МРТ, а при валидации 25 % инсультов за 7 суток пришлось на пациентов с суммой ≤ 4 . Поэтому низкий балл риск не исключает; в объём действий бригады шкала не входит.

6. По действующему алгоритму объём обследования и терапии при ТИА тот же, что при инсульте: пульсоксиметрия, ЭКГ, глюкометрия, термометрия, LAMS, венозный доступ, базовая терапия, эвакуация на носилках. Различие — в действиях при отказе от эвакуации: при ТИА и вертебробазилярной недостаточности актив передаётся в поликлинику, при инсульте и кровоизлияниях — в ОНМПВиДН, а при повторном отказе — в поликлинику. Различить ТИА и инсульт на месте невозможно, поэтому настойчивость в вопросе госпитализации одинакова.

Источники

- Алгоритмы оказания скорой и неотложной медицинской помощи. Приказ ДЗМ г. Москвы № 535 от 18.05.2023, раздел «Неврология», внутренние стр. 55–57 (инсульт, инфаркт мозга, субарахноидальное и внутримозговое кровоизлияние, транзиторная ишемическая атака, синдром вертебробазилярной артериальной системы).
- Клинические рекомендации «Ишемический инсульт и транзиторная ишемическая атака», ID 814, год утверждения 2024, пересмотр не позднее 2026. Всероссийское общество неврологов, Национальная ассоциация по борьбе с инсультом и др. — определения ОНМК, инфаркта, ТИА, ПНМК; приложение с шкалой ABCD² и шкалой LAMS.
- Клинические рекомендации «Ишемический инсульт и транзиторная ишемическая атака у взрослых», КР 171 — предыдущая редакция, на которую ссылается Приложение приказа ДЗМ № 535 (DI 171 от 01.09.2021).
- Easton J. D., Saver J. L., Albers G. W. et al. Definition and evaluation of transient ischemic attack: AHA/ASA scientific statement. *Stroke*, 2009;40:2276–2293.
- Nadarajan V., Perry R. J., Johnson J., Werring D. J. Transient ischaemic attacks: mimics and chameleons. *Practical Neurology*, 2014;14(1):23–31.
- Giles M. F., Rothwell P. M. Risk of stroke early after transient ischaemic attack: systematic review and meta-analysis. *Lancet Neurology*, 2007;6:1063–1072.
- Rothwell P. M., Giles M. F., Chandratheva A. et al. Effect of urgent treatment of transient ischaemic attack and minor stroke on early recurrent stroke (EXPRESS study). *Lancet*, 2007;370:1432–1442.
- Lavallée P. C., Meseguer E., Abboud H. et al. A transient ischaemic attack clinic with round-the-clock access (SOS-TIA). *Lancet Neurology*, 2007;6:953–960.

- Johnston S. C., Rothwell P. M., Nguyen-Huynh M. N. et al. Validation and refinement of scores to predict very early stroke risk after transient ischaemic attack (ABCD²). *Lancet*, 2007;369:283–292.
- Perry J. J., Sharma M., Sivilotti M. L. A. et al. Prospective validation of the ABCD² score for patients in the emergency department with transient ischemic attack. *CMAJ*, 2011.
- Amin H. P., Madsen T. E., Bravata D. M. et al. Diagnosis, workup, risk reduction of transient ischemic attack in the emergency department setting: AHA scientific statement. *Stroke*, 2023.
- Kerber K. A., Brown D. L., Lisabeth L. D. et al. Stroke among patients with dizziness, vertigo, and imbalance in the emergency department: a population-based study. *Stroke*, 2006;37:2484–2487.
- Charidimou A., Peeters A., Fox Z. et al. Spectrum of transient focal neurological episodes in cerebral amyloid angiopathy. *Stroke*, 2012;43:2324–2330.
- Wang Y., Wang Y., Zhao X. et al. Clopidogrel with aspirin in acute minor stroke or transient ischemic attack (CHANCE). *New England Journal of Medicine*, 2013;369:11–19.
- Johnston S. C., Easton J. D., Farrant M. et al. Clopidogrel and aspirin in acute ischemic stroke and high-risk TIA (POINT). *New England Journal of Medicine*, 2018;379:215–225.

Выходные данные

Материал: «Транзиторная ишемическая атака». Версия 1.1 от 19 августа 2026. Исправлено утверждение об исключении границы в 24 часа из определения ТИА: в действующих клинических рекомендациях МЗ РФ она сохранена.

Серия: «Крещение поворотом» — клинические разборы догоспитальной практики.

Лицензия: текст — Creative Commons «С указанием авторства — Некоммерческая — С сохранением условий» 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0). Копировать, печатать и раздавать коллегам можно свободно; продавать — нельзя.

Оговорка. Материал носит учебный характер. Он не является нормативным документом, не заменяет действующие протоколы, клинические рекомендации и распоряжения службы и не может использоваться как единственное основание для клинического решения. Дозы, показания и маршрутизацию необходимо проверять по действующим первоисточникам. Ответственность за клинические решения несёт медицинский работник, а не автор материала.

О клинических случаях. Случаи обезличены: нет имён, дат вызовов, адресов, номеров карт вызова, названий стационаров, бытовые детали изменены. Совпадения с чужой практикой возможны и неизбежны.

Нашли ошибку? Сообщить можно через раздел Issues репозитория проекта; исправление выходит новой версией, а изменение фиксируется в журнале изменений.